GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PAPER REVIEW · VACCINOLOGY · GERIATRICS

RSV 백신, 실사용 데이터로 가이드 재정비

JAMA Internal Medicine 2026.05 — 60세+ 성인 RSV 백신 real-world 효과·이상반응·고위험군 분석. 임상시험 효과(80-90%) vs 실사용(60-80%) 격차 + 가이드 보강.

JAMA Internal Medicine Vol 186 No 5 (2026.05) · Real-world cohort + case-control

★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

실사용 효과는 RCT보다 약간 낮지만 일관 유지 — 고위험군 우선 권고 강화

60–80
% 입원 예방

RSV 입원 예방 (real-world)
RCT 80–90% 대비 격차 있음

75+
세 우선

우선 접종 강화 군
(입원·중증 위험 가장 큼)

1–9/M
GBS

길랑-바레 증후군
(백만 명 당, 매우 드묾)

핵심 메시지 — RSV 백신(Arexvy·Abrysvo·mRESVIA)의 임상시험 효과 80-90%가 실사용에서 60-80%로 유지. 외래 RSV 감염 예방 효과 변동성 큼. 75세+·만성 심폐질환·면역저하 우선 권고 보강. 안전성은 접종 후 감시 자료와 함께 평가 (국소·전신 반응 일시적, 길랑-바레 매우 드묾). 아렉스비·아브리스보에는 미국 식품의약국 길랑-바레 위험 경고가 추가됨(2025). 가을 RSV 시즌 환자 상담 자료로 즉시 활용.

근거 · JAMA Internal Medicine 2026.05 · 다국 real-world cohort analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 60세+ RSV 백신이 중요한가

RSV는 영유아 질환으로 인식되지만 노인 RSV 입원·사망 부담 큼 — 인플루엔자 다음



RSV 침범 부위와 백신 보호 — 좌측: RSV 바이러스가 코·인두·기관지·폐 점막에 부착·복제. 우측 확대: 백신 유도 항체(Y 모양)가 점막에서 바이러스를 중화 — 하부 호흡기 진행·폐렴·입원 예방. 노인은 점막 면역 약화로 RSV 입원 위험 큼.

노인 RSV 부담

매년 노인 RSV 입원 — 미국 60–160k명 · 한국 추정 1–3만 명

노인 RSV 사망 — 미국 6–10k명/년 · 인플루엔자 사망과 유사 수준

입원 시 중증화 — 30-50% 폐렴·ICU·호흡부전 진행

만성질환자 위험 ↑ — COPD·천식·심부전·당뇨·면역저하 시 2-5배

장기요양시설 outbreak — 군집 감염 흔함, 사망률 10-15%

3종 백신 승인 — Arexvy(GSK)·Abrysvo(Pfizer)·mRESVIA(Moderna mRNA)

임상적 함의 — RSV는 인플루엔자만큼 노인에게 위험. 가을 시즌 인플루엔자·폐렴구균과 함께 RSV 백신 안내 필수.

근거 · CDC RSV epidemiology · 한국 호흡기학회 추정 · ACIP 60+ 권고 (2023)

JAMA Internal Med — Real-world Cohort + Case-Control

미국·유럽 관찰자료. 60세+ 접종군 vs 미접종군 비교. 효과·이상반응·고위험군 정의 재평가.

- **설계** Real-world cohort + test-negative case-control 혼합. RCT 한계 보강.
- **대상** 60세 이상 성인 (총 수십만 명) · 미국·EU·일부 아시아 청구·EHR 데이터
- **중재** Arexvy·Abrysvo·mRESVIA 접종군 vs 미접종 대조군
- **1차 endpoint** RSV 관련 입원 예방 효과 (laboratory-confirmed)
- **2차 endpoint** 외래 RSV 감염 · ICU 입원 · 사망 · 폐렴 진행
- **안전성** 길랑-바레·심막염·심근염·아나필락시스 신호 분석
- **지속성 평가** 1년·2년 시점 효과 비교 (booster 필요성)
- **고위험군 재정의** 연령·만성질환·면역저하 cluster 분석

근거 · JAMA Internal Med 2026.05 · CDC VISION network · EU EMA pharmacovigilance

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

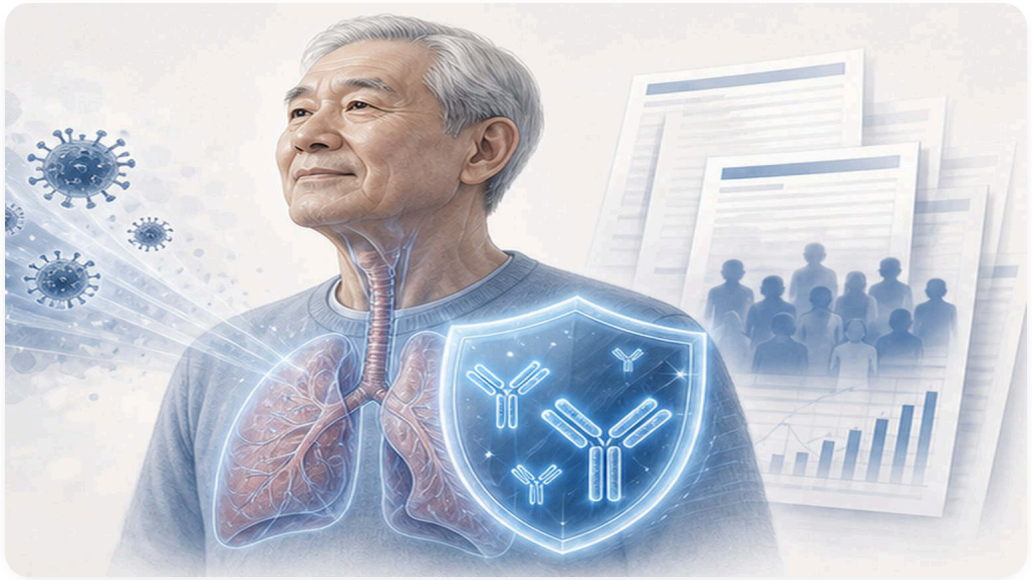
효과 — RCT vs Real-world 격차

RCT 효과 80-90% → 실사용 60-80%. 입원 예방은 견고, 외래 감염은 변동성 큼.

◆ 막대 폭 = 0–100% 효과 비례



해석 — RCT-Real World 격차는 일반적 백신 패턴 (모집단·바이러스 변이·접종 후 추적 차이). 외래 RSV는 검사 빈도·기준 차이로 변동성 큼. **입원 예방·ICU·중증 예방은 일관 유지** — 임상적으로 가장 중요한 결과.



지속성 — 1년 후 효과 유지 확인. 2년차 데이터 진행 중 — 부스터 권고 여부는 미확정. 현재는 1회 접종 권고 유지.

근거 · JAMA Internal Med 2026.05 efficacy analysis · vs RCT (AReSVi-006·MATISSE·ConquerRSV)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성 — 길랑-바레 경고를 함께 설명

국소·전신 반응 흔하나 일시적. 아브리스보·아렉스비는 미국 식품의약국의 길랑-바레 위험 경고가 추가됨(2025).

이상반응	빈도	지속	대응
국소 (주사 부위)	30–60%	1–2일	통증·발적·부종. 경증, 자가 호전. 진통제 필요 시
전신 (피로·근육통)	20–40%	1–2일	발열·두통·피로·근육통. 일시적. 일상 활동 영향 미미
길랑-바레	1–9/M	접종 후 6주	백만 명당 1-9예 — 매우 드묾. 미국 식품의약국이 단백 백신 2종에 위험 경고 추가(2025)
심막염·심근염	신호 약함	접종 후 4주	mRESVIA(mRNA)에서 약한 신호. 추가 관찰. 흉통·호흡곤란 시 평가
아나필락시스	극희귀	즉시	접종 후 15분 관찰 권고. 에피네프린·응급 키트 준비

근거 · JAMA Internal Med 2026.05 safety · FDA VAERS · EMA EudraVigilance · CDC ACIP

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

우선 접종 강화 — 4가지 고위험군

75세+·만성 심폐질환·면역저하·장기요양시설 거주자. Real-world 데이터로 보강된 우선순위.

PRIORITY · 01 · 최우선

75세 이상

RSV 입원·중증화 위험 가장 큼. 60–74세 대비 2-3배. **강한 권고**, 적극 상담 + 비용 안내.

PRIORITY · 02 · 강한 권고

만성 심폐질환

COPD·천식 (중등도+)·심부전·관상동맥질환. RSV 진행 시 악화·입원 위험 ↑. 가을 전 접종.

PRIORITY · 03 · 강한 권고

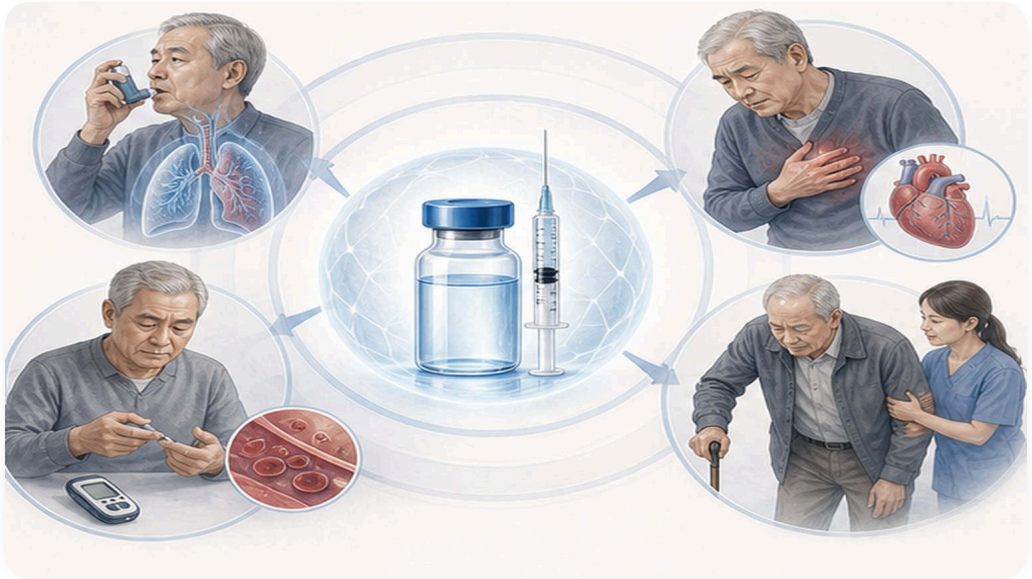
면역저하

장기이식·항암 치료·고용량 스테로이드·HIV·자가면역약. 백신 효과 다소 ↓이지만 이득 큼.

PRIORITY · 04 · 강한 권고

장기요양시설 거주

시설에서는 집단 감염과 기저질환을 함께 고려해 **접종을 적극 권고**한다.



근거 · JAMA Internal Med 2026.05 subgroup analysis · 미국 질병통제예방센터 성인 RSV 접종 지침(2024·2025 개정)

한국 도입 현황 + 비급여 비용

Arexvy·Abrysvo 일부 시행 · mRESVIA 도입 진행 · 비급여 ₩20–30만 · 식약처 승인 후

한국 도입 현황

Arexvy (GSK) — 2024년 식약처 승인, 일부 의원·종합병원 시행

Abrysvo (Pfizer) — 2024년 승인, 시행 확대 중

mRESVIA (Moderna mRNA) — 2024년 미국 승인, 한국 도입 진행

비급여 — 1회 접종 ₩20–30만 (의원 가격 변동)

국가예방접종(NIP) 미포함 — 현재 자비 부담. 2026-2027 NIP 검토 진행

대상 연령 — 75세 이상 전원 · 50–74세는 중증 위험요인이 있을 때 (미국 질병통제예방센터 기준)

실무 — 가을(9–10월) 인플루엔자·폐렴구균 접종 시 동시 안내. 환자 본인 결정.

비용 (한국 의원)

₩20–30 만/1회

의원·약물별 변동. 인플루엔자·폐렴구균(NIP 무료) 대비 부담 큼.

동시 접종 가능

+ 독감·폐렴 OK

CDC·EMA: 인플루엔자·폐렴구균 백신과 동시 접종 안전성 확인.

접종 시기

9–10월 가을 시즌 전

RSV 시즌 (11월–3월) 전 접종. 효과 발현 2-4주 소요.

근거 · 식약처 승인 현황 · 대한감염학회·대한노인병학회 권고 · 의원 비급여 가격 조사

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

권고 강도별 분류 — 4단계

강한 권고·권고·환자 선호 기반·비용 안내 — 각 단계별 상담 메시지 다름

대상	권고 강도	상담 우선순위	메시지
75세+	**강력 권고**	**1순위**	"가장 위험한 연령 — 접종 강력 권장. 비용 ₩20-30만"
50–74세 + 중증 위험요인	**위험군 권고**	**2순위**	"만성 심폐질환·면역저하 등 위험요인이 있으면 접종 권고"
60–74세 일반 건강	**정기 권고 아님**	—	"정기 접종 대상 아님. 60–74세는 중증 위험요인이 있을 때 권고"



근거 · 미국 질병통제예방센터 성인 RSV 접종 지침(2024·2025 개정) · 대한노인병학회 RSV 권고 · 환자 상담 가이드

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가을 시즌 환자 상담 4단계

9–10월 인플루엔자·폐렴구균 접종과 함께 RSV 백신 안내. 환자 결정 존중.

1

위험도 평가

우선순위 분류

연령·기저질환·면역저하 확인. 75세+ 또는 50–74세 만성 심폐질환 강력 권고. 일반 건강 60–74세는 현재 정기 접종 권고 대상이 아님.

2

정보 제공

효과·안전·비용 안내

"실사용 입원 예방 60-80%". 이상반응 1-2일 일시적. 길랑-바레 매우 드묾. 비용 ₩20-30만.

3

접종 시점

9–10월 우선

RSV 시즌 (11–3월) 전 접종. 효과 발현 2-4주. 인플루엔자·폐렴구균과 동시 접종 가능.

4

접종 후

15분 관찰·이상반응 안내

접종 후 15분 관찰 (아나필락시스). 1-2일 통증·피로 안내. 6주 내 신경증상 (저림·약화) 시 의료기관.

근거 · CDC ACIP counseling guide · 대한감염학회 가을 백신 가이드 · 의원 실무

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 주의사항 8가지

관찰연구 한계 + 한국인 데이터 부족 + 장기 효과·부스터 미확정

- **Real-world cohort** — Selection bias 가능. 접종군이 전반적 건강 우수할 가능성. RCT 인과성 추론 한계
- **RSV 진단 부정확** — 외래에서 RSV 검사 빈도 낮음. 외래 효과 추정 변동성 큼
- **한국인 데이터 부족** — 메타분석 대부분 서양인. 한국인 면역 반응·이상반응 패턴 보강 필요
- **장기 효과·부스터 미확정** — 1년 효과 유지 확인, 2년+ 자료 진행 중. 매년 vs 1회 접종 미결정
- **길랑-바레 신호 모니터링** — 드물지만 아브리스보·아렉스비의 미국 허가사항에 위험 경고가 추가됨(2025)
- **비급여 비용 부담** — ₩20-30만 자비. NIP 미포함 — 사회적 형평성 이슈
- **3종 백신 head-to-head 비교 부재** — Arexvy vs Abrysvo vs mRESVIA 직접 비교 RCT X
- **50-59세 데이터 제한** — RCT·real-world 60세+ 중심. 50–59세 고위험군은 미국 질병통제예방센터 접종 권고 대상

근거 · JAMA Internal Med limitations section · ACIP ongoing research · 한국 도입 단계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

가을 RSV 시즌 환자 상담 즉시 반영 가능한 임상 요약

1. RSV 백신 실사용 효과 **입원 60-80% 예방** — RCT 80-90% 대비 약간 격차이나 임상적 의미 큼
2. 우선 접종: **75세 이상 · 중증 위험군 50–74세**
3. **가을 9–10월 인플루엔자·폐렴구균과 동시 접종** — 안전성 확인. 효과 발현 2-4주
4. 한국 비급여 **₩20-30만**. 환자 본인 결정 존중 + 비용·효과 안내. NIP 도입 진행 중

다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

근거 · JAMA Internal Med 2026.05 · ACIP 2024·2025 개정 · 대한감염학회 · 대한노인병학회